



جامعة صالح بوبنيدر
قسنطينة 3
Université
Salah Boubnider
Constantine 3

Université de Constantine

Faculté de médecine

PERITONITES AIGUES

DR.H. BEDJAOU

I- DÉFINITION

- La PA représente la réponse inflammatoire aigue de la séreuse péritonéale à une agression bactérienne ou chimique
- L'infection péritonéale peut être diffuse ou localisée sous forme d'un ou de plusieurs abcès intra péritonéaux
- C'est une Urgence médicochirurgicale fréquente et grave, pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

II- ANATOMIE

- Le péritoine est une membrane séreuse richement vascularisée et innervée comportant deux feuillets en continuité l'un avec l'autre :
- ✓ Un feuillet pariétal tapissant les parois de la cavité abdominale.
- ✓ Un feuillet viscéral enveloppant tous les viscères de l'appareil digestif et la rate
- ✓ Ils déterminent une cavité virtuelle ; la cavité péritonéale qui ne devient réelle qu'en cas d'épanchement liquidien ou aérique car elle ne contient en réalité que moins de 50 ml de surfactant phospholipidique qui permet de diminuer la friction entre les organes surtout lors des mouvements respiratoires. Ce liquide contient des lymphocytes, et des macrophages.
- ❑ La disposition des organes et des méso au sein de cette cavité permet de distinguer des espaces dans lesquels circule ce liquide :
- ❑ Classiquement on décrit :
- L'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique séparés par le colon transverse et son méso.
- La région sous diaphragmatique droite séparée par le lobe droit du foie en deux espaces : la région inter-hépatico-diaphragmatique puis en dessous la région sous hépatique dont la partie la plus déclive en décubitus dorsal est appelée espace de MORISSON.
- La région sous diaphragmatique gauche
- L'arrière cavité des épiploons située entre la face postérieure de l'estomac et le pancréas en arrière.
- Deux gouttières pariétocoliques droite et gauche : en communication vers le bas avec la région la plus déclive qui est le cul de sac de DOUGLAS.

III- PHYSIOLOGIE

- Le péritoine est une membrane semi-perméable du fait de l'existence de la barrière péritonéo-vasculaire qui joue le rôle de véritable filtre.
- Il est doué de multiples fonctions, de sécrétion, de défense mais aussi de résorption.
- La circulation intra péritonéale des liquides se fait le long des gouttières pariéto-coliques droite et gauche, en haut vers la région sus et sous

hépatique, en bas vers le cul de sac de Douglas, expliquant les abcès sous phrénique, du cul de sac de Douglas ; et la bactériémie responsable de la défaillance multi viscérale.

- L'épiploon joue également un rôle très important dans la réponse immunitaire et la défense locale.

IV- ETIOPATHOGENIE

☐ Trois types de péritonites :

a- Péritonites primitives :

- Péritonites spontanées de l'enfant ou de l'adulte, mono microbiennes, à pneumocoques, à gonocoques...
- Iatrogènes : infection d'ascite chez le cirrhotique, ou lors de dialyses péritonéales,
- Péritonites tuberculeuses
 - ✓ Leur origine peut être hématogène, lymphatique, trans phallopiennes(= à partir des trompes de Fallope) : peu fréquentes

b- Péritonites secondaires :

☐ Deux mécanismes :

1- Par perforation : par ulcération, ou traumatisme

2- Par diffusion : à partir d'un foyer infectieux qui entraîne une dissémination péritonéale

c- Péritonite tertiaire :

- ✓ C'est une péritonite persistante malgré un traitement chirurgical.
- ✓ Tableau de sepsis avec défaillance poly viscérale, avec peu ou pas de liquide intrapéritonéal lors de la ré intervention ; (souvent à levures : candidas++)

V- PHYSIOPATHOLOGIE

☐ Diffusion systémique de l'infection

- La mobilisation des viscères abdominaux par les mouvements respiratoires favorise la diffusion du liquide septique à toute la cavité abdominale.
 - La relaxation expiratoire du diaphragme induit une pression intra abdominale négative qui favorise l'absorption par les stomates diaphragmatiques du liquide et des particules, présents dans le péritoine. Cette absorption explique que des bactéries inoculées dans le péritoine soient captées par les lymphatiques diaphragmatiques, apparaissent dans le canal thoracique en environ 6 minutes et en moins de 30 minutes dans la circulation systémique, la rate et le foie.
- ☐ L'infection péritonéale a ainsi, un retentissement local, dû à l'inflammation de la séreuse et à l'iléus qui l'accompagne ; et général dû aux modifications de

la volémie, et au syndrome toxi-infectieux dont l'évolution spontanée est une défaillance poly viscérale

A- Retentissement local :

- L'inflammation provoque la constitution d'un exsudat riche en protéines et en électrolytes.
- Pour limiter la diffusion de l'infection, il existe un iléus réactionnel d'où une séquestration liquidienne dans la lumière digestive, vomissements abondants, ou parfois une diarrhée aggravant les pertes liquidiennes (au total : 4 à 6 litres)

B- Retentissement général :

- ✓ Hémodynamique : par hypo volémie et sepsis
- ✓ Respiratoire : par réduction de la course diaphragmatique (douleur, distension abdominale), surinfection pulmonaire, œdème lésionnel, responsable d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe de l'adulte (SDRA)
- ✓ Rénal : insuffisance rénale fonctionnelle (par hypo volémie et sepsis) pouvant évoluer si le choc persiste vers une néphropathie tubulo- interstitielle aigüe
- ✓ Hépatique : hépatite aigüe bactérienne
- ✓ Hémorragie digestive : de stress
- ✓ Hématologique : hyperleucocytose, ou neutropénie dans les formes sévères
- ✓ Neurologiques : → confusion mentale
- ❑ **Pronostic :**
- La survenue de défaillances viscérales est un facteur de fâcheux pronostic.

VI-DIAGNOSTIC POSITIF

- ❖ Il est surtout clinique, les examens morphologiques s'adressent essentiellement aux formes trompeuses.

A-SYNDROME PERITONEAL :

Indépendamment de l'étiologie, une symptomatologie commune permet de porter le diagnostic de péritonite : C'est le syndrome péritonéal :

1-Signes fonctionnels :

- Douleur abdominale : constante, le plus souvent brutale, intense, d'emblée maximale, surtout en cas de perforation, aggravée par la respiration, son siège initial et son maximum d'intensité ont une valeur localisatrice mais non absolue.
- Nausées, vomissements : alimentaires, bileux puis fécaloïdes : inconstants.
- Arrêt du transit : conséquence de l'iléus peut être précédé par une diarrhée.

2-Signes généraux :

- Faciès pale, fièvre, pouls accéléré, tachycardie, voir état de choc toxi-infectieux avec chute tensionnelle, marbrures, frissons et oligurie...

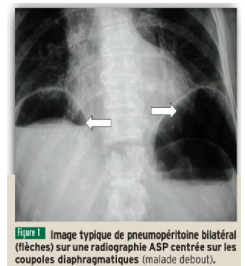
3-Signes physiques :

- ✓ **Palpation :**
 - **Contracture des muscles de la paroi abdominale :** maître symptôme, visible et palpable : la paroi ne respire pas qu'elle soit rétractée ou distendue par l'iléus, ne se laisse pas déprimer : elle est invincible, permanente, et douloureuse (ventre de bois) ; typiquement généralisée, elle peut être localisée dans l'un des quadrants de l'abdomen.
 - **Défense abdominale :** peut la substituer, là la palpation douce peut la vaincre.
- ✓ **Percussion :**
 - Disparition de la matité pré hépatique.
 - Matité des flancs.
 - Tympanisme global : en présence d'un iléus paralytique.
- ✓ **Touchers pelviens :** douloureux ; témoignent de l'inflammation du cul de sac du Douglas.

B-EXAMENS COMPLEMENTAIRES :

1-Radiologiques :

- ☐ **Téléthorax :** élément du bilan préopératoire et de surveillance.
- ☐ **Radiographie de l'abdomen sans préparation :** face, debout ou assis, plus un cliché centré sur les coupes :
 - **Signe direct :** pneumopéritoine : croissant gazeux sous diaphragmatique uni ou bilatéral
 - **Signes indirects :**
 - occlusion mixte traduisant l'iléus reflexe
- ✓ **Grisaille diffuse ;** de l'épanchement intra péritonéal
- ☐ **Echographie :** peut montrer un épanchement intra péritonéal, ou signes évocateurs d'une étiologie particulière
- ☐ **Tomodensitométrie :** recherche de collections ou d'abcès intraabdominaux, et des bulles de gaz témoignant d'une perforation digestive ; ou signes évocateurs d'une étiologie particulière
- ☐ **Lavement aux hydrosolubles :** peut visualiser une perforation gastrique ou colique par fuite extra luminale du produit de contraste
- ☐ **Laparotomie exploratrice :** si nécessaire



2-Biologiques:

- **NFS :** hyperleucocytose > 15000/ mm³

- CRP élevée
- Bilan d'hémostase et groupe sanguin (bilan pré opératoire)
- Ionogramme sanguin, urée et créatinine sanguines

➔ Ils guident la réanimation, et ont un intérêt pronostique et évolutif

VII- FORMES CLINIQUES

a- Péritonites localisées:

- Elles correspondent aux collections abcédées localisées au cul de sac de Douglas le plus souvent, mais l'abcès peut être sous-phrénique, sous hépatique ou de l'arrière cavité des épiploons.
- ❖ *Cliniquement, elles se caractérisent par un syndrome infectieux sévère et des signes physiques étroitement liés au siège de la collection. Le diagnostic repose sur l'imagerie (Echographie abdomino-pelvienne et surtout tomodensitométrie*
- ❖ *Les abcès les plus fréquents :*

1- Abcès sous-phrénique : survient dans un contexte post-opératoire de chirurgie sus-mésocolique. Se traduit par :

- Des signes d'irritation diaphragmatique +++ :
- ✓ Toux, dyspnée, hoquet, gêne respiratoire et douleur scapulaire
- ✓ Rx: surélévation de la coupole diaphragmatique, épanchement pleural, atélectasie

2-Abcès du Douglas:

- ✓ Syndrome pelvien (pollakiurie, ténesme et douleur hypogastrique).

b-Péritonites asthéniques:

- Elles se rencontrent essentiellement chez le sujet âgés, tarés, immunodéprimés, sous corticothérapie ou d'antibiothérapie intempestive.
- Elles correspondent souvent à des péritonites négligées :
- Signes généraux très importants et graves +++
- Elles donnent un tableau d'occlusion fébrile avec un météorisme important sans contracture, le plus souvent.
- Le pronostic est sévère. Intérêt de l'échographie et le scanner+++.

VIII- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- ✓ *Infarctus du Myocarde*
- ✓ *Colique hépatique*
- ✓ *Colique néphrétique*
- ✓ *Ascite infectée*
- ✓ *Insuffisance rénale inexpliquée*
- ✓ *Pneumopathie basale*

IX- FORMES ETIOLOGIQUES

A-Péritonites par perforation gastrique ou duodénale :

- Deux origines : ulcéreuse ou tumorale

a- Perforations ulcéreuses: les plus fréquentes

- ❖ Clinique : tableau souvent typique
- ✓ Douleur brutale, épigastrique, intense en coup de poignard, à irradiation dans la région scapulaire, parfois dans la fosse iliaque droite faisant évoquer une appendicite aiguë
- ✓ Contracture généralisée
- ✓ Prise de médicaments ulcérogènes (AINS, aspirine), syndrome ulcéreux, ou antécédents ulcéreux connus
- ✓ ASP : Pneumopéritoine
- ❖ La perforation sur estomac vide est une péritonite chimique, stérile avant la 6ème heure (absence de fièvre) évoluant vers la péritonite infectieuse généralisée

NB/ Un ulcère gastrique est un cancer jusqu'à preuve du contraire

b- Perforations tumorales:

Cancers gastriques ou lymphomes : pronostic sombre

B-Péritonites appendiculaires :

- ❑ Les péritonites par perforation sont graves d'emblée :
- Début brutal dans la FID
- Signes infectieux sévères (T à 39°C, pouls accéléré, parfois état de choc)
- A l'examen : défense généralisée, voire une contracture
- Des formes asthéniques, occlusives, pseudo tumorales se rencontrent volontiers chez les sujets âgés

C- Péritonites par perforation colique :

- ✓ Siège : souvent sur le sigmoïde, fréquemment secondaire à une sigmoïdite ou à un cancer
- ✓ Autres causes : colites inflammatoires ou ischémiques, fécalomes. Les perforations iatrogènes sont plus rares

1-Les perforations des sigmoïdites diverticulaires sont les plus fréquentes, par diffusion, par rupture d'un abcès péri sigmoïdien ou par perforation d'un diverticule infecté ; L'épanchement est alors soit purulent, soit pyo stercoral :

- ✓ Douleur brutale ; début : fosse iliaque gauche ; diffuse rapidement à l'ensemble de l'abdomen
- ✓ Nausées ou vomissements
- ✓ Arrêt du transit
- ✓ Fièvre élevée,
- ✓ Altération rapide de l'état général, voire état de choc
- ✓ A l'examen : contracture généralisée, prédominant dans FIG

- ✓ Pneumopéritoine important, bilatéral

2- Perforations cancéreuses :

- ✓ Diastasiques : Siégeant au niveau de la tumeur
- ✓ Diastatiques : en amont d'un cancer occlusif

Symptomatologie identique à celle des perforations diverticulaires

D- Péritonites méso cœliaques :

- ✓ Les diverticules du grêle : de l'iléon terminal(D.de Meckel), parfois du jéjunum ou du duodénum, ou diverticulose diffuse du grêle
- Deux tableaux :
péritonite aigue franche ou occlusion fébrile
- ✓ Perforation lors d'une poussée de la maladie de Crohn
- ✓ Les Entérites nécrosantes et les colites ischémiques peuvent évoluer vers la péritonite par perforation
- ✓ Typhoïde, brucellose..
- ✓ Perforations tumorales

E- Péritonites biliaires :

- Complication redoutable de la cholécystite aigue, qu'elle soit lithiasique ou non,
- Soit par diffusion, soit par perforation d'une cholécystite gangreneuse, ou d'un pyocholécyste ou par rupture secondaire d'un abcès péri vésiculaire.
- Perforation d'un cancer de la vésicule
- Péritonites biliaires post-traumatiques, postopératoires, ou après biopsie du foie
- Elles se traduisent par :
- ✓ Douleur brutale de l'hypocondre droit irradiant vers l'épaule droite, souvent accompagnée de nausées, ou de vomissements
- ✓ Souvent syndrome septique sévère
- ✓ Contracture ou défense de l'hypocondre droit qui diffuse rapidement à tout l'abdomen

NB/ la présence d'un ictère : inconstant, le début dans l'hypocondre droit, les antécédents de lithiase. Orientent vers l'origine biliaire

☐ Examens complémentaires :

- ✓ **ASP** : montre parfois des calculs radio opaques dont la présence en dehors de l'arbre biliaire, et en l'absence d'iléus biliaire, est en faveur d'une perforation vésiculaire
- ✓ **Échographie abdominale** : épanchement intra péritonéal, signes de cholécystite aigue, dilatation des voies biliaires, lithiase du cholédoque

F- Péritonites génitales :

- ☐ La péritonite génitale est une Pelvipéritonite d'origine salpingienne :
 - Soit par diffusion d'une salpingite
 - Soit par rupture d'un pyosalpinx : se manifeste par :

- ✓ Fièvre à 39°-40°C
- ✓ Douleurs pelviennes ou hypogastriques diffusant vers le haut, avec irritation vésicale(pollakiurie) et rectale(ténesme)
- ✓ Vomissements
- ✓ Arrêt du transit
- ✓ A l'examen : douleur et défense sus pubiennes à la palpation
- ✓ Touchers pelviens douloureux (cri du Douglas) et un pyosalpinx peut être palpé

G- Péritonites urinaires :

- ❑ Rupture traumatique de la voie excrétrice haute ; ou de la vessie, plus rarement en amont d'un obstacle réalisant un uropéritoine ; ou par diffusion ou rupture d'une Pyonéphrose
- ✓ **ASP** : éventuelle lithiase rénale radio opaque
- ✓ **Echographie** : épanchement intra ou rétro péritonéal

H- Péritonites postopératoires :

- De diagnostic difficile, et de pronostic sévère.
- Complication gravissime de la chirurgie digestive, souvent secondaire à la désunion d'une suture ou d'une anastomose ; plus rarement à une pancréatite nécrosante, ou une complication à distance du geste chirurgical : perforation d'ulcère

X-TRAITEMENT

1-Péritonites secondaires :

A- Traitement médical :

- ❑ Avant, pendant et après le geste chirurgical
- ❑ Il vise à combattre l'infection, et le retentissement général de la péritonite. Il comprend :
 - ✓ Une antibiothérapie intraveineuse à large spectre (active sur aérobies et anaérobies) à base de bêtalactamines type céphalosporines (céfoxitine..), un imidazolé (flagyl®..) et un aminoside (gentamicine..). Elle sera adaptée secondairement en fonction des résultats de l'antibiogramme obtenu après hémocultures et culture de liquide péritonéal prélevé pendant l'intervention. Ce traitement est en général poursuivi 7 à 15 jours.
 - ✓ Un remplissage souvent important et rééquilibration électrolytique
 - ✓ Une nutrition parentérale hypercalorique
 - ✓ Un contrôle des grandes fonctions vitales (cœur, poumon, reins) avec traitement des défaillances viscérales

B- Traitement chirurgical :

- ❑ **Le but** est triple
 - Assurer la disparition de la contamination bactérienne permanente

- Evacuer le pus et les substances étrangères
- Assurer un drainage efficace de la cavité péritonéale pour éviter la constitution d'abcès intra péritonéaux ou d'une nouvelle péritonite

❑ **Moyens :**

1- Laparotomie :

- ✓ La voie d'abord doit être médiane pour une exploration complète de la cavité péritonéale. (Transversale, dans un pli de l'abdomen, souvent chez l'enfant).

❑ On procédera à :

- ✓ Une toilette péritonéale après prélèvements bactériologiques
- ✓ Un traitement étiologique (appendicectomie, cholécystectomie, stomies (en cas de perforation grêlique ou colique) ...
- ✓ Drainage large des zones déclives
- ✓ Fermeture pariétale.

2- Coelioscopie : Principales indications :

- ✓ Les perforations ulcéreuses duodénales.
- ✓ Les péritonites appendiculaires en l'absence de plastron ou d'iléus paralytique important.

C- Radiologie interventionnelle :

En cas de lésions cloisonnées (abcès), l'alternative à la réintervention est le drainage percutané écho ou scano- guidés, en l'absence de lésions associées (lâchage de suture ou d'anastomose) que le plus souvent, seule la chirurgie peut traiter.

2- Péritonite primaire :

- ❑ Le traitement est avant tout médical : à base d'antibiothérapie probabiliste jusqu'aux résultats bactériologiques définitifs.
- ❑ En plus d'un drainage per cutané écho ou scanno guidé d'éventuel(s) abcès.

3- Péritonite tertiaire :

- ❑ Adjonction d'un traitement antifongique (amphotéricine B) au traitement antibiotique déjà instauré, du fait de la présence très fréquente de candida.